

ALBERTA STROKE PROGRAMME EARLY CT SCORE (ASPECTS)

J.T. Camino A.

El Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS) es un sistema estandarizado de interpretación de la TAC cerebral para los ictus isquémicos de la circulación anterior.

PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN:

El análisis se realiza sobre dos cortes axiales de la TAC

- El primero a nivel del tálamo y ganglios de la base (plano A).
- El segundo adyacente al borde superior de los ganglios de la base, sin que se visualicen los mismos.(plano B).

En los dos planos, el territorio de la arteria cerebral media se divide en 10 regiones, valorando cada una en 1 punto.

- M1 : región cortical anterior de la ACM.
- M2 : región cortical lateral al ribete insular.
- M3 : región cortical posterior de la ACM.
- M4, M5, M6 : región cortical anterior, lateral y posterior de la ACM, aproximadamente 2 cm por encima de M1, M2, M3, respectivamente.(Plano B).
- M7 : Núcleo lenticular.
- M8 : Núcleo caudado.
- M9 : cápsula interna.
- M10: ribete insular.

Se sustrae un punto por cada región donde se aprecia un cambios isquémico precoz (Hipoatenuación o efecto de masa local)

- Una puntuación del ASPECTS inferior o igual a 7 se asocia a una morbilidad elevada y mala recuperación funcional.
- Una puntuación ASPECTS de 10 significa que el TAC es normal.
- Una puntuación de 0 implica una afectación difusa de todo el territorio de la ACM (arteria cerebral media).

El riesgo de hemorragia intracerebral siguiendo la terapia trombolítica es mayor si la puntuación es igual o menor de 7.

La escala del Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) se desarrolló para cuantificar los cambios isquémicos tempranos en la tomografía computarizada (TC) en pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular isquémico agudo en el territorio de la arteria cerebral media. Se diseñó para ayudar a seleccionar a los pacientes que tenían un mayor beneficio clínico para el tratamiento con fibrinolíticos, para detectar el riesgo de hemorragia y como factor pronóstico.

Esta escala se puede calcular en los estudios de TC (tanto en la TC basal como en la angio-TC) y de resonancia magnética en la secuencia de difusión, que es la herramienta más

sensible para la detección de la isquemia cerebral, aunque, en la mayor parte de los centros, la TC sigue siendo la prueba diagnóstica más utilizada por su rapidez y accesibilidad, y porque descarta de manera fiable la presencia de sangrados.

La escala del ASPECTS es cuantitativa y divide el territorio vascular de la arteria cerebral media en 10 regiones que se evalúan en dos niveles: el nivel ganglionar y el supraganglionar. El límite es la cabeza del caudado. Cualquier hipodensidad parenquimatosa sugestiva de infarto en los cortes axiales a la altura de la cabeza del caudado o por debajo se adjudica a la región del ASPECTS ganglionar, donde hay siete regiones (los segmentos M1, M2 y M3, la ínsula, el núcleo caudado, el núcleo lenticular y la cápsula interna); las lesiones por encima de la cabeza del caudado corresponden a la región supraganglionar, y se valoran tres regiones (M4-M6). Partiendo de una puntuación inicial de 10 puntos, se va restando un punto por cada región afectada.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.neurologia.com/articulo/2021298>
- [REV NEUROL 2022;74:1-7]. PMID: 34927699DOI: <https://doi.org/10.33588/rn.7401.2021298>
- http://ictus.sen.es/?page_id=82